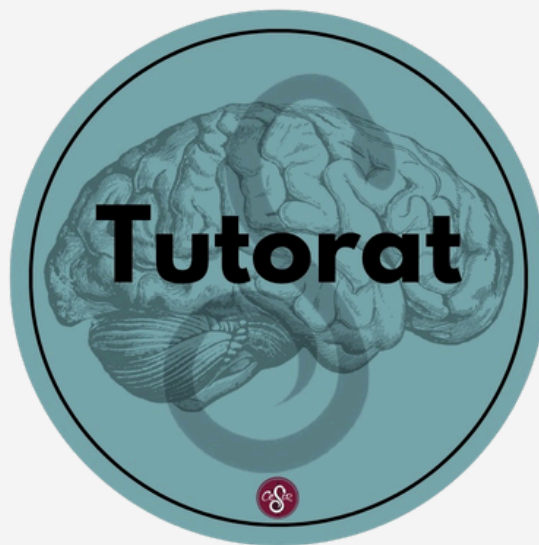
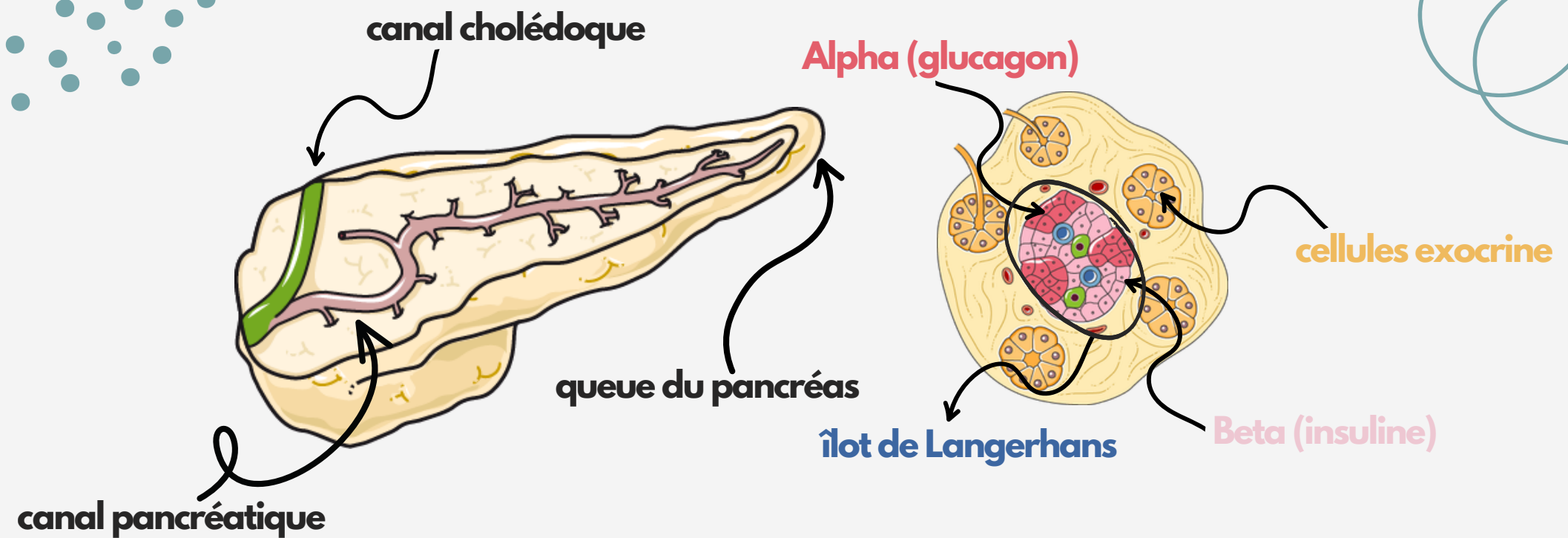


C'est quoi...

La Pancréatite chronique



Rappel physiologique



Le **pancréas** est un organe essentiel du système digestif et endocrinien. Il se situe derrière l'estomac et remplit deux fonctions principales : **exocrine**, en produisant des enzymes digestives pour décomposer les aliments dans l'intestin grêle

et une fonction **endocrine**, en libérant des hormones comme **l'insuline** et le **glucagon** pour réguler la glycémie. Son bon fonctionnement est **crucial** pour la digestion et le métabolisme énergétique.

endocrine + exocrine
= amphicrine

Fonction amphicrine

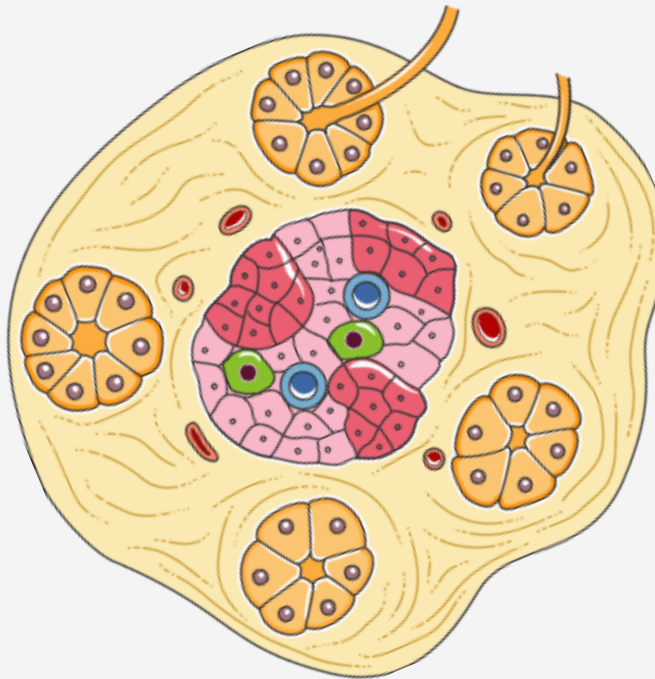
Le pancréas est une glande **amphicrine**, ce qui signifie qu'il a à la fois des fonctions **exocrines** et **endocrines**. Les fonctions exocrines impliquent la sécrétion de sucs digestifs, tandis que les fonctions endocrines concernent la libération **d'hormones** dans le sang

Cellules Alpha Glucagon

Le glucagon est une hormone produite par les cellules alpha des îlots de Langerhans dans le pancréas. Il joue un rôle crucial dans la régulation de la glycémie en augmentant le taux de sucre dans le sang.

Cellules Beta Insuline

L'insuline est une hormone essentielle produite par le pancréas, plus précisément par les cellules bêta des îlots de Langerhans. Son rôle principal est de réguler la glycémie (le taux de sucre dans le sang)
HGT = 0,80 - 1,20

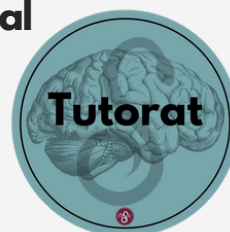


Cellules exocrine Acinis

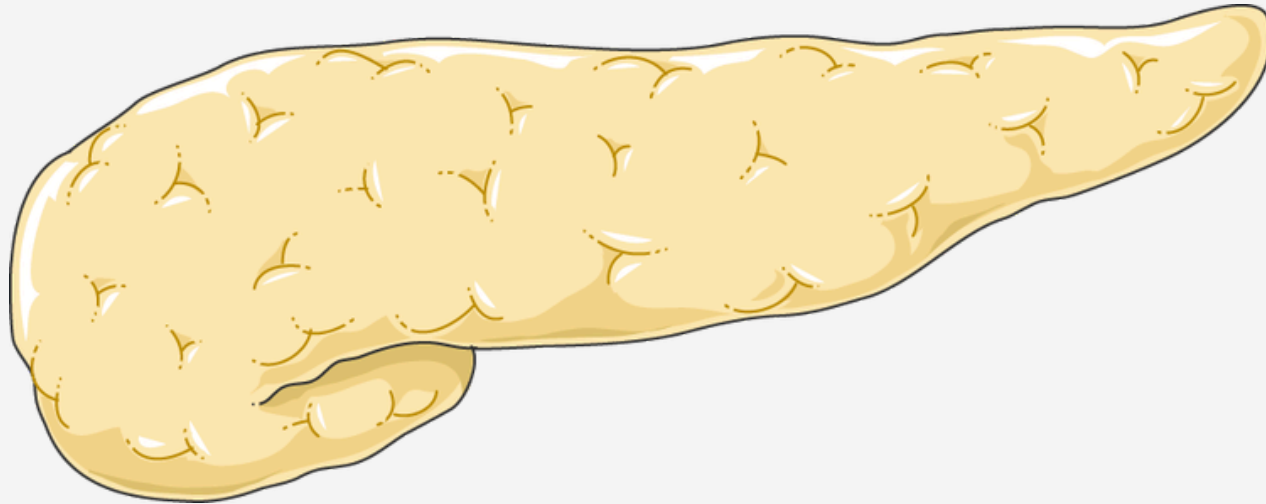
La fonction exocrine du pancréas concerne la production et la libération d'enzymes digestives essentielles pour la digestion des aliments. Ces enzymes sont sécrétées sous forme de suc pancréatique, qui est déversé dans le duodénum via le canal pancréatique.

Cellules Delta somatostatine

Son rôle principal est d'inhiber la sécrétion d'autres hormones et d'agir comme un régulateur du système endocrinien et digestif, elle freine la libération d'insuline et de glucagon modulant ainsi la glycémie



pancréatite



La pancréatite chronique est une **inflammation prolongée** du pancréas qui entraîne des lésions structurelles permanentes et ainsi une **fibrose pancréatique**

Le pancréas possède des mécanismes de **protection** contre l'**auto-digestion**, mais lorsqu'ils ne sont plus efficaces cela entraîne :

- Désorganisation architecturale et une calcification
- Lésion du parenchyme
- Hypertension et obstacles canaux
- Perte d'auto régulation de la trypsine (enzyme des sucs digestifs)

Étiologie : **alcool** / **hypercalcémie** / **génétique** / **tabac** / **auto-immune** / **tumeurs**



Symptômes

Cliniques : **Douleurs** / **Amaigrissement** / **Cholestase** / **Stéatorrhée** /

Douleurs : situées à l'épigastre, irradiant dans le dos, souvent très intenses et insomniantes, aggravées par l'alimentation et calmées par la position chien de fusil

Amaigrissement : peut être en lien avec la prise d'alcool et avec l'insuffisance pancréatique

Cholestase : diminution ou arrêt du flux biliaire ce qui entraîne un ictère rétentionnel avec des selles blanches et des urines foncées

Stéatorrhée : symptôme caractérisé par une quantité anormalement élevée de graisses dans les selles qui deviennent claires, pâteuses, abondante, grasses et malodorantes.



Examens

Les examens d'imagerie pour la pancréatite :

Echographie : pas très utile

TDM : visualisation du parenchyme pancréatique

IRM : visualisation des canaux principaux et secondaires

Endoscopie : parenchyme et canaux / ponction

Les examens biologiques :

Pancréatite aiguë : lipasémie et défaillances viscérales

Insuffisance pancréatique exocrine : stéatorrhée (+ de 5g/j) et élastase fécale

Insuffisance pancréatique endocrine : glycémie et HbA1c



Traitement

compenser l'insuffisance exocrine

contrôler le diabète du patient

contrôle et gestion de la douleur

arrêt des toxiques : alcool, tabac, etc

traiter les complications

